0:00
вебинара Меня зовут Елена Олеговна Самохина и я рада всем кто к нам
0:06
присоединился Я думаю что мы Достаточно уже подождали и Можем начинать а Уважаемые коллеги сегодняшний вебинар
0:14
был заявлен с двумя преподавателями Ну вот к сожалению у Татьяны Евгеньевны также возникли какие-то непредвиденные
0:20
обстоятельства и мы будем начинать с вами а без неё Я надеюсь мы справимся
0:26
если у неё появится возможность она к нам присоединится по порядку проведения вебинара Я думаю
0:33
что все вы примерно уже осведомлены как они проходят в начале мы с вами повторим
0:39
и сделаем акценты на тех теоретических вопросах которые вы уже изучали в
0:46
лекционном материале данного модуля А по ходу если у вас возникают вопросы
0:53
пишите их пожалуйста в чат После такой небольшой теоретической сти
1:01
возможность послушать ответы на вопросы которые будут в чате или задать вопросы
1:07
лично включив микрофоны пока же я прошу во
1:12
время теоретической такой части держать микрофончик выключенными Вы помните Да что всё что происходит рядом с вами всё
1:19
транслируется в общий эфир и хочу Вам напомнить что модуль наш посвящен
1:27
первичной профилактике социально заболеваний и также в этой теме Мы рассматриваем очень важный Аспект
1:35
посвященный управляемым факторам риска хронических неинфекционных заболеваний
1:40
которые является важнейшим аспектом первичной профилактики и является также
1:46
тем Полем благодатным полем деятельности куда вы можете направить свои усилия по
1:53
работе с клиентами основные темы напомню вам
2:01
хорошо известно это заболевания которые занимают лидирующие
2:07
позиции по заболеваемости инвалидизации смертности среди населения это
2:12

управляемые факторы риска на которые мы можем с вами воздействовать в целях профилактики это лабораторные
2:19
исследования функциональные инструментальные исследования которые нам помогают контролировать состояние
2:25
организма и мы изучаем вопросы их периодичности и интерпретации также в
2:32
модуль входят вопросы онконастороженность и диспансеризации в различные возрастные
2:37
периоды а при изучении данного модуля Вы должны были узнать какие
2:44
заболевания занимают лидирующие позиции по инвалидизации смертности среди населения Что такое собственно
2:51
управляемые факторы риска и как ими управляет То есть это конкретный
2:56
инструмент которому мы должны вас научить сегодня с помощью каких методов обследования
3:03
можно выявлять хронические заболевания на самых ранних стадиях какие показатели
3:09
требуют контроля Как часто их назначать как интерпретировать результаты Почему важна
3:14
онконастороженность Каковы основные задачи диспансеризации как её пройти людям и какие объёмы
3:22
диспансеризации в разные возрастные периоды Что такое группа здоровья и как
3:27
собственно экс диагностику клиента и как проводить
3:32
мотивационное консультирование вот этот Круг вопросов в который входит данный модуль и часть из них мы с вами сегодня
3:39
повторим закрепим и может быть какие-то дополнения ещё внесём Итак первый вопрос который мы
3:47
должны рассмотреть и поставить акцент это какие же заболевания занимают лидирующие позиции по инвалидизации и
3:55
смертности среди населения группа социально значимых заболеваний
4:02
это те болезни которые возникают и распространяются в определённой степени
4:09
в зависимости от социально-экономических условий жизни населения и соответственно большой

4:17
удельный вес создают на систему здравоохранения государства и вносит
4:23
свой вклад Да в состояние здоровья населения и требуют проведения эффективной
4:30
профилактики с привлечением не только медицинских работников но и общественности органов власти
4:36
образования культуры и так далее и собственно Вот таких специалистов которыми вы готовитесь стать
4:43
специалистами по Анти консультирования А что входит в этот перечень социально
4:50
значимых заболеваний Ну соответственно с постановлением Правительства Российской Федерации вот у нас утверждён такой
4:56
перечень Турку передающиеся преимущественно половым путём гепатиты В иц передающиеся
5:05
парентерально ВИЧ всем известный вызванный вирусом
5:12
иммунодефицита человека все злокачественное новообразование то есть
5:17
большая группа заболеваний сахарный диабет психические расстройств расстройства поведения и большая группа
5:26
болезней характеризующихся повышенным кровным давлением вот эта большая группа и составляет
5:32
перечень социально значимых заболеваний то есть тех заболеваний которые вносят максимальный вклад в инвалидизации в
5:40
смертность населения то есть прямым образом влияют на продолжительность жизни людей
5:47
а при этом эти заболевания к счастью уже хорошо изучены Да хорошо известны
5:54
факторы которые приводят к их возникновению и соответственно уже
6:00
ответы на вопросы как же их избежать самых распространённых болезней в мире
6:06
А ну как пример как иллюстрация на данном слайде Вы можете видеть что
6:12
здоровое здоровье сердца зависит от трёх факторов а здоровое питание разумные
6:19
физические нагрузки и полноценный сон вот эта Триада Она работает безотказно и
6:24
многократно снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений

6:30
что касается такой грозной группы как онкологические заболевания злокачественные новообразования рак как
6:37
мы называемый в однород но здесь три главных фактора из которы из-за которых развивается более половины случаев
6:43
онкологии и на первом месте стоит безусловно курение на втором месте ожирение и на
6:50
третьем злоупотребление алкоголя избегая вперёд сразу мы видим что все эти
6:55
факторы они у нас Какие являются управляемые да то есть мы имеем возможность на них воздействовать к
7:04
счастью ещё одна большая группа большая группа имеется в виду по
7:10
количеству по численности заболевших и она увеличивается прогрессивно с каждым
7:15
годом во всех развитых и развивающихся странах мира это сахарный диабет
7:20
сахарный диабет в первую очередь имеется в виду сахарный диабет второго типа который возникает чаще у людей с
7:27
избыточной массой тела вре инсулинорезистентности и здесь лучшее
7:33
средство профилактики и защиты от осложнений а также дополнительный фактор лечения один из главных - это физические
7:40
нагрузки физические нагрузки которые приводят к нормализации массы тела нормализация
7:47
обмена веществ к уменьшению уровня гликемии само по себе это очень хорошая
7:53
профилактика и также средства лечения диабета Кару
7:59
Бронхо лёгочных заболеваний здесь конечно же на первое место выходит отказ от
8:05
курения важнейший Фактор А тоже как мы видим как мы знаем управляемый Хотя
8:11
управляемый сложно но тем не менее здесь огромное поле для работы
8:18
и также весьма распространённым состоянием в мире
8:24
которое также увеличивается прогрессивно год от года Является группа психических расстройств
8:30
в том числе пограничных психических расстройств имеется в виду не только

8:35
такие основные психиатрические заболевания но и поники пограничные
8:41
расстройства которые могут возникать время от времени и у вполне здоровых людей связанных с
8:47
какими-то жизненными ситуациями и здесь очень важно учить людей умением управ
8:54
стресом
9:00
является полноценный достаточный сон доказано что это тоже является
9:05
хорошей профилактикой психических особенно пограничных расстройств
9:12
А во всём мире правительство всех стран озабочены состоянием здоровья своего
9:19
населения и принимаются вот такие вот Стратегии разрабатываются в каждом
9:24
государстве стратегии формирования здорового образа жизни населения профилактики контроля не инфекционных
9:31
заболеваний вот в частности вот у нас в России была утверждена такая стратегия в 2020 году и а постоянно идёт работа
9:40
продолжается и [музыка] э в общем-то работа здесь непочатый край
9:47
потому что цель - это снижение В итоге заболеваемости и предотврати мой
9:52
смертности от неинфекционных заболеваний что должно логично привести к увеличению ожидаемой продолжительности здоровой
10:00
жизни да которые собственно и является целью дуго государства который заботится
10:07
о своём населением предполагается что реализация
10:14
данной стратегии у нас приведёт к как раз тому самому контролю над
10:21
управляемыми факторами риска то есть снизится потребление табака снизится потребление алкоголя
10:30
уве доля граждан которые систематически занимаются физической культурой
10:35
спортом увеличится количество людей страдающих ожирением снизится прирост
10:42
этой проблемы и всё это приведёт в конечном итоге к снижению смертности в трудоспособном возрасти и увеличит
10:50
продолжение продолжительность жизни населения

11:00
который очень важен в данной теме Это чисто практическая такая вещь
11:07
алгоритм профилактического мотивационного консультирования который был представлен
11:13
вам уже в лекции но важные аспекты которого я бы хотела с вами сегодня
11:19
повторить закрепить потому что это тот инструмент которому ставим цель вас
11:25
научить вы будете с ним работать или у ва возникли какие-то вопросы то
11:32
пожалуйста если хотите что-то уточнить Напишите в чат Или давайте в конце
11:37
обсудим А собственно Из чего состоит эффективная
11:43
профилактическая мотивационная консультирование здесь важно три
11:49
составляющие первая составляющая - это информировать клиента то есть рассказать
11:55
ему о том какие у него имеются факто риска Да что он
12:02
может предпринять какие есть методы самоконтроля какие есть методы
12:10
оздоровления то есть дать ему максимально полную информацию о том состоянии в котором он находится и как
12:17
это состояние можно улучшить с учётом современных возможностей Да но этого мало мало его информировать
12:26
второй важнейший пункт это нужно его зави к то чтобы он принял какие-то
12:33
решения по изменению образа жизни по оздоровлению то есть С его стороны
12:40
должны последовать какие-то активные действия под вашим руководством и ваши задача его к этому максимально
12:47
мотивировать и когда уже клиент у нас будет замотивирован когда он абсолютно
12:53
готов эм дест
12:59
е нужно третьим пунктом обучить обучить то
13:04
есть дать ему практические навыки оздоровления поведенческих привычек то
13:11
есть максимум конкретных адресных практических Советов
13:16
с обучающими какими-то моментами Ну например обучить измерять артериальное

13:23
давлени если кто-то не умеет правильно это делать и так дале дале
13:30
три составляющие эффективного профилактического мотивационного консультирования клиента это
13:36
информирование затем мотивирование и
13:43
обучение какие моменты очень важны для повышения
13:49
эффективности чтобы у вас был результат что
13:54
важно важно максимально общаться
14:01
донести ему доходчиво Понятно на языке ему
14:08
[музыка] понятном привлекать его к обсуждению обязательно с тем чтобы любое принятое
14:15
решение по оздоровлению было вашим совместным решением при этом Вы должны
14:21
говорить с ним открыто искрен ЭО ите
14:29
отри эмоций людей не надо запугивать их нужно информировать и учитывать также
14:39
что Согласно закону психологии клиент воспринимает не только то что мы говорим
14:45
но и то как мы говорим то есть сначала оценивают подачу информации
14:52
сначала оценивают нас да то есть вольно или невольно каждый раз Слушая какое-то
14:57
сообщение мы реагируем на то кто говорит Как говорит и только в последнюю очередь
15:03
на то что говорит
15:08
а советы Какие должны быть советы Какие должны быть рецепты рекомендации они
15:16
должны быть обязательно чёткие конкретные доступные для понимания
15:24
человека того уровня развития с которым вы общаетесь
15:29
Используйте приём обратной связи То есть даже если Вы уверены что Вы
15:35
чётко очень доступно и понятно объяснили что вы хотите донести до
15:42
вашего клиента Обязательно поинтересуйтесь как он понял как он это
15:48
понял Да действительно ли он понял как он будет это делать Что он об этом

15:54
думает то есть Используйте приём обратной связи
16:02
Какие основные проблемы Какие основные проблемы Вас ждут когда вы начнёте
16:09
практиковать Когда вы начнёте применять вот эту методику профилактического
16:15
мотивационного консультирования с чем вы столкнётся особенно когда вы начнёте пытаться
16:20
корректировать вот те самые управляемые факторы ри которые вы выявите у ших клиентов
16:29
увидите что человек очень часто будет сопротивляться особенно на первых этапах Почему Потому
16:37
что факторы риска поведенческого характера чаще всего людьми воспринимаются как жизненные
16:44
удовольствие соответственно наше вмешательство в представление человека
16:50
выглядит как попытка лишить его привычного способа получения удовольствия
16:59
хорошо понят привычка хорошо вкусно покушать ведёт к часто к избыточной
17:05
массе тела у кого-то даже к ожирению и когда мы начинаем говорить о том что питание нужно перестраивать человек
17:12
понимает что его сейчас лишат вот всего вкусного чего он
17:18
привык Ну ладно еда есть же ещё у нас курение алкоголь ре алкоголь вроде всем
17:24
понятно что привычки вредные но тем менее возможность например
17:30
непринуждённо общения какого-то повышения чувства уверенности в
17:36
себе возможность завязывать какие-то контакты новые знакомства и так далее
17:44
А многие из клиентов любят проводить не секрет время за гаджетами за компьютером
17:53
есть интерма у нас да и понятно что многочасовое Сиде компьютером Я уж не
18:00
говорю про тех людей которые по необходимости по роду своей деятельности
18:05
по работе проводят много времени за компьютером все эти люди страдают
18:10
конечно же от гиподинамии что тоже является фактором риска
18:17

и фактор стресса который присутствует в жизни наверное всех современных людей
18:25
степени люди также
18:30
начинают снимать с ним бороться с помощью нездоровых методов нездоровые методы это тот же алкоголь тоже курение
18:38
таже обильная еда мы знаем привычку заедать стресс Особенно это вот у женщин
18:43
распространено больше наверно у мужчин больше алкаголь и собственно всё это я говорю к тому что
18:52
вы нока
18:58
чаще всего не приводят к их выполнению именно по той причине что направлены на
19:05
лишение привычного удовольствия у людей соответственно наша с вами задача -
19:10
уметь предлагать здоровую альтернативу уметь находить эту альтернативу вместе с
19:16
клиентом а подходящую ему индивидуально под его характер образ жизни характер
19:23
профессиональной деятельности и так далее и так далее То есть недостаточно просто сказать Уважаемый вам нужно
19:31
бросить курить нужно ещ выяснить Почему человек курит и предложить ему какую-то
19:37
замену здоровую А мы с вами проговорили Про трудности и
19:45
теперь ошибки самые частые ошибки тоже нужно знать Которые
19:52
допускают люди при профилактическом консультировании дабы их стараться
19:58
не совершать ошибки приводят к чему к тому что клиент теряет интерес к тому что вы
20:05
говорите да например информационная перегруженность это вот очень часто
20:11
особенно у начинающих спикеров консультантов коучей
20:17
они хотят они прошли учёбу и они переполнены знаниями они хотят своими
20:23
знаниями поделиться с людьми и буквально обшивают как вот ведро холод воды на
20:29
голову бедным клиентам всё-всё-всё что они только знают у клиента начинает кружиться голова Он информационно
20:36
перегружен он не понимает как он с это с этим валом информации может вообще существовать дальше справиться и

20:42
соответственно теряет интерес к работе с вами поэтому не Старайтесь
20:48
выдать всю информацию сразу не Старайтесь
20:56
использовать непонятные медицинские термины такой вот наукой
21:02
язык который Казалось бы должен добавлять убедительности вашим словам он тоже
21:09
вызывает отторжение у людей которые не понимают Просто этих они не обязаны
21:14
знать специальные медицинские термины поэтому Старайтесь объяснять всё
21:20
максимально простыми доступными словами ещ одна ошибка когда мы даём
21:27
какую-то рекомендацию но нечётко разъясняем как это нужно
21:32
делать как это нужно делать то есть максимально подробно проговаривать в данно в конкретном случае когда вы
21:40
что-то рекомендуете что вы хотите какой алгоритм действий должен быть и какой должен быть на выходе
21:47
результат то есть максимально чётко разъяснять и пользоваться ещё раз приёмом обратной связи то есть
21:54
рассказали что вы хотите получить от клиента чему вы хотите его научить уточните понял он вас или не понял может
22:01
он объяснить что он будет делать насколько так сказать
22:08
Он в курсе всего или у него какие-то
22:14
может быть вопросы сразу по ходу возникнут и потребуется разъяснения
22:19
А ещё одна ошибка Может быть она не так часто встречается но она тоже очень
22:26
создат большие проблемы а когда со стороны консультирую
22:31
а недостаточно эмпатии недостаточно внимания к чувствам клиента к его
22:37
проблемам А если клиент вам доверяет какую-то
22:44
проблему которые у него существуют ни в коем случае нельзя её обесценивать говорить что это ерунда Что это вот
22:50
что-то такое надуманные что в общем-то это легко решается и если человек с вами делится

22:56
проблемой значит для него это нелегко решается чит для него это значимо и он
23:01
ждёт от вас сочувствия понимания и какой-то помощи какой-то
23:07
помощи поэтому Будьте очень внимательны и если клиент
23:15
вам рассказывает что он не может выполнить какую-то рекомендацию потому что вот у него такая-то такая-то
23:20
проблема значит прежде чем настаивать на выполнение рекомендаций нужно попытаться
23:26
вместе с ним найти решение этой проблемы которая ему мешают которая его отвлекает
23:32
от вот этой вот вашей стратегии его оздоровления не даёт ему возможности
23:38
реализовывать ваши рекомендации и пятая ошибка - это
23:44
отсутствие конкретных адресных Советов А ну вот проверяя ваши домашние задания Мы
23:52
часто очень радуемся Когда вы
23:58
э в общем Какие конкретные очень советы по пунктам целый план но иногда может
24:06
быть за недостатком времени может быть ещё из-за недостатка опыта а советы бывают такие достаточно общие и как раз
24:14
не конкретные А ну например там изменить пищевое поведение Да там оздоровить питание за
24:22
счёт там снижение жира увеличение клетчатки это конечно всё верно но это а
24:29
совет не конкретный и не адресный То есть я надеюсь что всё-таки работая с
24:34
конкретным человеком ваши советы будут звучать не в общем виде Да а
24:42
очень-очень Конкретно подробно расписаны Да какие продукты мы ограничиваем Почему
24:48
какие продукты мы добавляем В каком количестве Почему тоже касается физической нагрузки увеличить количество
24:55
физической нагрузки Что это такое Ну человек понимает как он должен увеличить количество физической нагрузки А если вы
25:01

ему конкретно сказали что а с завтрашнего дня Да скажем три раза в
25:07
неделю получасовая Прогулка пешая в течение там 30 минут по парку вы просто
25:13
ходите быстрым шагом в комфортном темпе и это ваше увеличение физической
25:20
нагрузки на данном этапе то это будет очень конкретно и очень
25:26
адресным Я надеюсь что вот эти пять вы запомните и не будете будете
25:31
стараться не допускать при работе с вашими клиентами А и мы с вами подошли вот к
25:42
самому собственно ключевому слайду собственно к алгоритму профилактического
25:48
мотивационного консультирования которому мы хотели вас обучить он состоит из
25:55
пунктов Вы можете его себе распечатать как-то иметь под рукой чтобы помнить
26:01
потому что каждый пункт действительно важен консультирование может происходить
26:08
и в каких-то более сокращённых вариантов какие-то пункты когда-то Может быть вы
26:13
опускайте но Поверьте это самый полный самый такой вот эффективный
26:20
алгоритм здесь в общем-то принци нез ничего добавить
26:28
м работать именно начинать в соответствии с этим алгоритмом первым пунктом здесь
26:35
естественно стоит первичная диагностика как всегда мы выявляем
26:40
проблему в данном контексте нашего занятия предметом нашей диагностики
26:47
являются факторы риска управляемые факторы риска хронических инфекционных
26:52
заболеваний то есть то с чем мы планируем работать диагности вторым пунктом мы
27:00
Пациенту должны рассказать всё что мы выявили то есть информируем его о том
27:07
результате которые данная диагностика выявила оцениваем у него суммарный риск
27:12
и даём разъяснение даём разъяснение что это означает для него дальше Мы объясняем
27:20
объясняем как вот эти выявленные факторы ри будут влиять негативно в будущем на
27:26
его здоров ка есть возможности для снижения этого
27:33
риска основы именно необходимость работы с этими

27:38
рисками дальше Мы обязательно должны сделать немножко паузу и оценить
27:43
отношение клиента всему тому что мы ему рассказали то есть готов ли он к
27:49
изменению своего образа жизни
27:58
начнём Давать ему рекомендации он может быть нас чистой за вежливости выслушает
28:04
Но если он не готов соответственно результата может не быть никакого он просто ничего не будет делать поэтому
28:11
обязательно работаем активно оцениваем отношение его всему сказанному нами
28:17
выясняем готов ли он меняться готов ли он к активным действиям И уже потом
28:23
пятым пунктом если он готов хотя бы в какой-то степени
28:28
то нужно составить и обсудить с ним конкретный план оздоровления данного
28:38
клиента когда план составлен и обсужден согласован с клиентом то здесь уже
28:46
наступает время дать конкретные персональные рекомендации А по
28:52
модификации выявленных управляемых факторов риска проинформировать о целевых уровнях факторов риска к которым
28:59
мы стремимся например уровень артериального давления уровень глюкозы в крови уровень холестерина и так
29:08
далее после того как мы дали персональные рекомендации мы уточняем
29:13
опять используем приём обратной связи насколько клиент Хорошо понял рекомендации и спрашиваем если мы
29:21
сомневаемся что он понял пром повторить осно и сри
29:28
же Мы ждём от него действия дальше очень важно восьмым пунктом научить клиента умениям по
29:35
самоконтролю если он начинает работать по снижению например артериального
29:41
давления или по снижению веса он должен знать как он будет себя контролировать
29:47
Да как он будет снижа снижать свою массу тела какими темпами как он будет следить
29:53
за уровнем артериального давления А как он будет контролировать себя по другим
30:01

параметрам Как часто он будет обращаться к врачам для того чтобы сдавать анализы
30:06
какие-то проходить лабораторные инструментальные обследования и так далее
девятый пункт алгоритма
30:15
консультирования это контроль контроль и повторения то есть
30:23
при каждой встрече мы контролируем
30:28
рекомендаци и повторяем их если какие-то рекомендации уже выполнены и не
30:34
актуальны мы добавляем новые но большинство наших рекомендаций они
30:40
долгосрочные они остаются с с клиентами надолго Поэтому мы каждый раз
30:45
проговариваем что мы продолжаем двигаться в таком-то направлении делать то-то
то-то и
30:51
то-то и завершающий пункт алгоритма очень
30:57
приятный очень позитивный такой укрепляющий
31:03
отношения клиента с консультантом с коучем это обязательно одобрять
31:10
позитивные изменения даже если вам кажется что их нет что они совсем
31:16
небольшие незначительные очень важно в плане поддержания мотивации у ли в плане
31:24
поддержания доверия квам вла по этому трудному пути очень важно
31:31
одобрение позитивных изменений То есть каждый раз пожалуйста находите
Старайтесь за что вашего клиента
31:37
похвалить и он вам будет за это благодарен возрастающим желанием
31:44
выполнять ваши рекомендации
31:50
и теперь следующая часть нашего сегодняшнего разговора
31:58
это разбор домашних заданий Я хочу сделать небольшую паузу и спросить у вас по
тому о чём мы уже поговорили Есть ли
32:05
у вас какие-то вопросы вот прямо сейчас насущные
32:11
которые хотелось бы осветить или
32:20
обсудить Я открываю чат в чате вы пока ничего не написали кроме приветствия
32:33

если вопросы возникают вы их или пишите в чат я буду туда периодически
32:38
заглядывать или просто поднимайте руку У вас есть такая возможность или поскольку
32:44
нас немного включаете микрофон и я думаю что мы друг друга
32:51
услышим и Можем немножко позволить себе обсудить ли вопросов Пока нет тогда
32:59
давайте двигаемся дальше и разберём ваши домашние
33:06
задания ещё раз я хочу проговорить чему Мы вас хотели научить Как вы должны были
33:12
эти задания делать задание я знаю вас по желанию
33:18
и несколько домашних заданий Я уже проверила написала свои комментарии в
33:24
принципе справляетесь справляетесь
33:29
немножечко не совсем вот хватает мне чёткости и конкретики в ваших
33:35
рекомендациях но мы только учимся Я думаю что всё это к вам придёт итак у
33:41
вас было по данной теме три домашне задания можно было выбрать одно на выбор
33:47
кто-то сделал два кто-то одно кто-то все три в любом слу
33:58
посмотрим какие там есть нюансы первое задание мы просили провести диагностику
34:04
своего клиента либо родственника знакомого на наличие управляемых факторов риска и оставить для него
34:10
рекомендации по первичной профилактике хниз с учётом выявленных факторов
34:18
риска и по этому заданию А вот эта э
34:23
иллюстрация очень хорошая шпаргалка - это напоминание чтобы Вы не забыли ни
34:29
один из факторов риска о котором вы должны подумать знать и спросить и
34:36
выявить Имеется ли он у вашего клиента данная иллюстрация - это вот такая
34:41
информационная
34:49
листовочник напечатали для врачей первичного звена и врачи у нас которые работают в отделениях медицинской
34:56
профилактики в городских поликлиниках используют как такой информационный раздаточный материал для

35:01
пациентов собственно О чём это нам напоминает о том что все факторы риска
35:07
мы видим делятся на те которые мы не можем изменить и те на которые мы
35:13
повлиять можем к счастью тех на которые мы можем повлиять намного больше чем тех
35:21
которые мы не можем изменить мы не можем к сожалению изменить возн
35:28
наследственность ту информацию которую он у наследовал ту предрасположенность заболевания которую он у наследовал от
35:34
своих родителей вот эти три основных фактора они Неуправляемые мы их отстав в сторону мы
35:43
здесь ничего сделать с вами не можем Но есть большой перечень управляемых
35:50
модифицированных факторов риска которые существенно повышают риск четыр основных
35:56
груп инфекционных заболеваний а именно сердечнососудистых
36:02
онкологических бронхолегочных и сахарного диабета вот эти четыре
36:09
основные группы заболеваний - это как раз то ядро которое обуславливает основную
36:18
заболеваемость инвалидность и смертность совестно небольшую продолжительно жиз
36:25
среди нания борьба с этими факторами риска Это как раз борьба за то чтобы
36:31
люди были более здоровыми жили более долго Да и старели
36:37
медленнее собственно та цель которую преследует вся наша программа
36:44
обучения и Напоминаю Вам что факторы риска который вы выявляется у своих
36:50
клиентов Это курение нездоровое питание низкая физическая активность
36:57
если есть данные лабораторного обследования то повышенный холестерин возможно повышенный уровень глюкозы
37:04
крови артериальная гипертония стресс тревога депрессия
37:10
ожирение или избыточная масса тела и избыточное потребление алкоголя вот эти
37:16
факторы риска вам предлагалось все проанализировать а выявить у ваших клиентов и составить план а действий как

37:25
же с ними бороться
37:31
для убедительности для мотивирования вам предлагался
37:38
использовать предлагался использовать инструмент шкалу скор который определяет риск смерти от
37:46
сердечно-сосудистого заболевания в ближайшие 10 лет у людей в возрасте от 4
37:52
до 65 лет я думаю что высь пользоваться Судя
37:58
по тому какие ответы были присланы Вы хорошо разобрались Как работать с этой табличкой здесь две части таблицы для
38:06
женщин для мужчин необходимо поставить совместить возраст у пациента его
38:14
систолическое артериальное давление уровень холестерина и в зависимости от курящий не курящий мужчина или женщина
38:21
определить какой у него будет риск смерти от сердечно-сосудистого
38:26
заболевания Ну такая грозная достаточно информация
38:32
такой инструмент больше конечно им пользуется врачи но вы для убедительности не сгущая
38:39
конечно краски а излагаю просто всё спокойно грамотно убедительно можете
38:45
этот инструмент использовать В работе также появился я вас хочу
38:52
познакомить дополнительный инструмент это обнов с 2
38:59
и с 2 то есть для пациента в возрасте от 70
39:08
до 89 лет появилась дополнительная шкала а
39:13
преимущество собственно принципиальное отличие ср2 от
39:19
ср1 в том что она оценивает не вероятность фатального
39:24
сердечно-сосудистого события в течение десятилетней перспективе фаталь - это значит
39:31
смертельные событие А вероятность любого сердечно-сосудистого события как смертельного так и не смертельного то
39:38

есть мы знаем что инфаркт он не обязательно приводит к летальному исходу но тем не менее является тоже Грозным
39:45
таким состоянием которое существенно изменяет качество жизни людей то есть жизнь людей до инфаркта после
39:53
инфам торас после инсульта Даже если он не фатальный он может иметь очень
40:00
катастрофические последствия для здоровья для жизни людей Поэтому вот это табличка алгоритм скор 2 он как раз
40:10
а оценивает риск любого и фатального и
40:15
не фатального события а принцип тот же самый курящие не
40:21
курящие мужчины женщины возраст уровень холестерина уровень систолического
40:27
артериального давления подставляй и
40:33
оцениваете какой данного клиента риск Я думаю что вы справились все с
40:41
этим заданием если были какие-то сложности по выявлению факторов риска Задайте вопрос в чат Напишите Ире
40:50
[музыка]
40:57
здесь Хотелось бы с вами проговорить ещё раз это рекомендация касающаяся физической активности хотя у вас будет
41:04
целый отдельный модуль Где вы будете изучать всякие лечебные
41:12
программы лечебную физкультуру как активизировать пациента в соответстви
41:18
состоянием его здоровья Как подобрать ему физическую активность это будете рассматривать но В общих чертах просто
41:26
Вы должны знать регулярная физическая активность она
41:31
показана практически всем абсолютно всем пациентам но за редким редким
41:37
исключением все кто может самостоятельно двигаться они как правила двигаются
41:45
недостаточно при том что доказано что регулярная физическая активность она снижает риск практически всех тех
41:54
состояний всех тех хронических инфекционных заболеваний которые вот
42:01

представляют для нас основную проблему то есть физическая активность она не просто снижает массу тела Да она борется
42:09
с артериальной гипертонией с сахарным диабетом с остеопорозом она а
42:16
предупреждает А те же самые инфаркты инсульты А
42:22
некоторые виды рака и в конечном итоге преждевременную смерть
42:27
то есть люди которые хотят продолжительно активно жить на свете сохраняя здоровье
42:36
они Без физической активности реализовать Такие планы ну вряд ли
42:42
смогут поэтому этот момент который индивидуально прорабатывается с каждым
42:49
пациентом по принципу что даже небольшая физическая активность лучше чем её
42:55
полное отсутствие Да Единственное что конечно же без фанатизма нужно начинать
43:01
внедрять эту рекомендацию у людей абсолютно физически тренированных у людей имеющих хронические заболевания
43:08
обязательно после консультации с врачом Ну вот в среднем можно сказать
43:15
что существенную пользу для здоровья оказывает не менее 150 минут в недев
43:27
который можно считать просто ходьбу да и ходьба - это сейчас одна из самых таких
43:35
действенных эффективных и безопасных универсальных рекомендаций то
43:40
есть много исследований о том что ходить лучше чем бегать ходить лучше чем
43:46
заниматься какими-то серьёзными особенно экстремальными видами спорта то есть ходьба - это такое универсальное
43:52
средство оздоровления которое подходит для всех и вы наверное знаете что а
43:59
появились всякие цифры а 10.000 шагов в день для предотвращения инфаркта
44:05
инсульта для здорового сердца а будьте аккуратны с этой рекомендацией
44:12
пожалуйста да до 10.000 шагов нужно
44:18
доходить не всем кому-то может быть достаточно будет и п ише и
44:24
се до де дойдут са здоровые больше это очень здоровые
44:31

тренированные индивидуально то есть начинаете увеличивать нагрузки всегда постепенно с
44:37
учётом состояния клиента и с учётом рекомендаций врача после его
44:43
обследования состояния его уточнения здоровья
44:49
а второе задание у нас было посвящено
44:54
вопросу никотиновой то есть курение
45:00
табака вам предлагалось провести оценку никотиновой зависимости своего клиента
45:05
либо родственника знакомого и составить для него пошаговый шаг пошаговый план
45:12
отказа от курения а данное домашнее задание вызывает у нас
45:19
обычно наибольшее количество вопросов эта тема такая актуальная для многих
45:25
живот [музыка] собственно говоря основные вопросы
45:33
посвящённые данной теме они освещены в очень хорошей статье
45:40
которую я упоминала в лекции и предлагала вам Её для самостоятельного
45:45
изучения но я знаю что не все доходят до этого
45:54
источника тем не менее я бы хотела вот сейчас расставить акценты и познакомить Вас с
45:59
этой статьёй поподробнее статья авторов гамбарян
46:05
драки алгоритмы оказания помощи курящим в системе здравоохранения Позвольте
46:10
спросить вы курите журнал профилактическая медицина на основании данной
46:17
статьи были выпущены методические рекомендации для врачей которые оказва
46:27
бросить курить пациента данная статья она написана с
46:32
одной стороны для врачей опубликована в медицинском журнале но тема настолько
46:38
всем понятная знакомая Да несложная во
46:43
многом и доступным языком всё это излагается поэтому большую часть
46:50
инструментов которые в ней приводятся можно использовать вполне на вашем
46:57

уровне на уровне коуча консультанта по антиэйдж по зош А всё это вам очень
47:04
доступно и основные вопросы а которые возникают при выполнении
47:10
данного домашнего задания - это как определить тип курительного поведения и
47:16
как провести оценку никотиновой зависимости ответы содержатся в данном
47:22
источнике Ну давайте а всё-таки посмотрим
47:27
Ну актуальность наверное не буду об актуальности говорить все мы знаем что курящих Людей
47:35
очень много Да у нас примерно 30% взрослого населения курит и Хотя по
47:42
данным миздрава курить стали меньше тем не менее проблема ещё остаётся очень
47:50
актуальной ВС боль Люде Осо молодых сво
47:58
же прио э привы хотят активно хотят от не
48:03
избавиться но не всегда знают как это правильно сделать и прежде чем
48:09
приступить к решению этой проблемы нужно оценить степень никотиновой зависимости
48:15
для оценки степени никотиновой зависимости во всм мире используется
48:25
тест очень простой очень простой но достаточно информативный всего шесть вопросов нужно
48:33
задать Пациенту шесть вопросов с предложенными вариантами ответов на него
48:39
и каждый ответ оценен какое-то количество баллов сумму баллов нужно посчитать и по сумме баллов определяется
48:48
степень никотиновой зависимости вопросы
48:53
очень строго отобраны оче обосновано включено в этот
49:00
тест Я думаю что даже здесь комментировать не очень нужно вы
49:05
согласитесь что от того как быстро человек после
49:11
того как проснётся тянется за сигареты да по тому как быстро ему нужно выкурить
49:17
первую сигарету Конечно же можно судить о степени его никотиновой зависимости
49:23

потому как тяжело воздерживаться человеку от курения в тех местах где оно запрещено тоже можно судить
49:33
а от какой сигареты было бы тяжелее всего воздержаться от утренней или
49:38
вечерней Да сколько сигарет в день Вы выкуривает Но это понятно Да сколько чем
49:46
больше выкуривает человек тем соответственно сильнее у него тяга сильнее пристрастия А когда он больше
49:53
курит утром на протяжении дня Тоже имеет значение и очень важный
50:00
вопрос Курит ли человек во время болезни когда он должен придерживаться постельного режима вот самые заядлые
50:07
злостные курильщики они курят даже когда
50:13
болеют лежат в постели с температурой врач пришёл назначил лечение сказал не курить врач
50:20
ушёл нот в его
50:27
баллы за ответы на данные шесть вопросов вы получите результат от ноля до Т
50:32
баллов это низкий уровень зависимости это самое Благодатное поле
50:39
для вашей именно деятельности потому что здесь как
50:44
правило зависимость носит больше психологический характер и работа именно
50:51
с психологическими факторами можно помочь человеку
50:56
относительно несложно с этой проблемой справиться там где сумма баллов
51:03
увеличена до 4п здесь мы диагностируем по результатам
51:08
теста средний уровень зависимости и здесь уже одних только разговоров мотивационного
51:17
нашего консультирования рекомендаций может быть
51:22
недостаточно здесь уже включаются физиологически ни да человек при попытке
51:29
бросить курить испытывает физически выраженный дискомфорт и здесь уже весьма желательно подключать специалистов
51:36
врачей которые оказывают помощь которые используют препараты никотин
51:43

заместительной терапии здесь это уже возможно и
51:49
желательно Если же у нас определяется высокий уровень зависимости
51:55
по количеству балов до здесь совершенно точно попытки
52:01
отказаться от курения особенно резкие попытки будут вызывать довольно неприятные ощущения в организме
52:09
и самостоятельно человеку справится с этими ощущениями бывает сложно многие
52:16
делают попытки но не выдерживают и здесь обязательно
52:22
подключаются в качестве дополнительной помощи препараты
52:27
никотин заместительной терапии и препараты других Гру групп которые помогают нормализовать именно вот это
52:35
нарушение физического состояния связанно с отменой и никотина то есть с уровнем
52:44
высокой никотиновой зависимости уже просто консультанты позо
52:49
коучи никогда практически не справляются без помо врачей Хотя
52:56
пога только на никотин замещающие препараты а лекарства
53:01
лекарствами ваша помощь тоже очень важна это и настрой это и поддержка это
53:08
многие-многие советы потому как побороть эту
53:18
привычку ну здесь у меня видимо пол сюда в с
53:26
на данном вебинаре о разнице между обычными
53:32
электронными сигаретами вейпы кальяны Что лучше что
53:39
хуже Что безопаснее Что выбирать в качестве наименьшего зла Да из всех зол
53:45
ну здесь предвосхищая ваши
53:51
вопрос я сразу скажу
53:56
[музыка] разница только в способах доставки способах доставки и количестве тех
54:05
веществ Да которые содержатся в табачном дыме а главно из которых конечно же
54:12
никотин но нужно понимать что способ доставки разный а эффекты в общем-то они конечные

54:20
одинаковые поэтому нет безопасных способов доставки нити
54:27
есть нюансы связанные с тем что в обычных сигаретах кроме никотина
54:32
содержится ещё огромное количество всевозможных консервантов канцерогенных веществ
54:39
гербицидов пестицидов тем чем обрабатывают этот Бабак пока его выращивают сушат хранят и так далее а
54:49
электронные сигареты они не сжигают табак как обычно содержат
54:56
специальная жидкость и там часто содержится солевой никотин который
55:02
является более концентрированным который всасывается быстрее и в больших дозах попадает в организм поэтому зависимость
55:10
от электронных сигарет развивается как уже показано быстрее гораздо Тем более
55:17
что курить их можно дольше чаще даже в в тех местах
55:22
где невозможно курить обычные сигареты поэтому су электронные
55:28
сигареты наносят даже больше вред чем обычное курение потому что сума
55:34
получается больше доза отдельная История
55:39
проы это вот у подростков появилась такая несколько лет назад
55:45
мода жидкости для парения сейчас мода сходит на нет как мне кажется
55:57
з жи молодых Люде связа с токсическим поражением гх
56:04
очень напоминающим по клинике тяжёлую пневмонию попадают в
56:10
реанимацию с тяжёлым поражением даже Их переводят на искусственное дыхание Вот
56:18
Но есть
56:26
пройдёт эта жидкость она как оказалось содержит тоже большое количество веществ
56:34
которые серьёзно поражают лёгкие но а давайте всё-таки вернёмся по
56:43
э ближе к нашему практическому вопросу как же мы будем оказывать помощь А тем
56:50
кто желает бросить курить А что мы будем использовать какие инструменты

56:57
но в первую очередь я хочу вас призвать к такому пониманию которое есть у врачей
57:03
понимание заключается в том что курение - это не вредная привычка а настоящая
57:08
болезнь но при этом не должна быть никакого пессимизма бросить курить не
57:14
просто но можно Всё зависит от того насколько осознанно насколько
57:20
решительно наш клиент захочет это сделать захочет бросить курить
57:27
Наша задача в любом случае при каждой встрече мотивировать его на отказ от курения если он уже пытается или пытался
57:34
то хвалить поддерживать и в общем-то искать те инструменты которые помогут
57:42
ему эту проблему победить а индивидуально что мы делаем на
57:49
индивидуальном уровне конечно очень важно Определить тип курительного поведения то есть выяснить причину по
57:55
которой коно данный человек курит соответственно если мы будем знать причину мы будем знать как с ней
58:01
бороться Какие подсказать альтернативные способ либо получение удовольствия либо
58:07
поднятие настроения либо решение проблем зависимо от того почему зачем человек
58:12
нас курит в качестве альтернативы может быть всё что угодно начиная от занятий спортом танцами общения чтения освоение
58:21
каких-то новых технологий методов релаксации йога медитация Ну всё что
58:26
угодно а если клиент желает бросить курить то
58:35
очень важно порекомендовать ему общение с единомышленниками то есть с людьми
58:40
которые уже бросили или бросают курить очень важен обмен опытом у таких людей есть
58:49
полно форумов в интернете где такие люди общаются делятся своими впечатлениями
58:54
очень поддерживают друг друга потому что сложно и всегда проще делать с кем-нибудь в
59:01
компании заодно когда ты не один на один борешься когда ты знаешь что вот есть ещё единомышленники которые тебя
59:08

поддержит которые что-то посоветуют и которые у которых самое главное это уже
59:14
получилось которые могут заразить своим положительным примером Ну советы разные я наверное не
59:23
буду зачитывать они на слайде представлены [музыка]
59:28
есть очень много литературы которая и на просторах интернета доступны в книжных магазинах
59:37
Как бросить курить как я бросил курить как я бросал курить всевозможные
59:42
названия иногда Вы тоже мне их присылаете спрашиваете мнение но мнение
59:48
здесь может быть только одно ВС что способно помочь человеку избавиться от этой
59:55
пробле имеет право быть и если человек найдёт свой способ это будет
1:00:00
замечательно если он найдёт его с вашей помощью совсем прекрасно но если вы
1:00:08
видите что у человека средний или даже высокий
1:00:14
уровень зависимости никотиновой да то есть сильная очень тяга к курению то
1:00:20
обязательно не тяните время не затягивайте Посоветуйте ему
1:00:27
специализированный кабинет в отделени медицинской профилактики там где врачи
1:00:32
специально обученные оказывать помощь с этой проблемой а могут оказать ему не
1:00:37
только моральную психологическую консультативную поддержку но и
1:00:43
медикаментозную сами Ну к сожалению как не врачи по
1:00:50
понятным причинам не можете рекомендовать препараты таким пациентам Но вы должны
1:00:57
им рассказать что если у него не получается самостоятельно если очень
1:01:02
выраженные вот эти Сид симптомы отмены если очень плохое физическое самочувствие то эта проблема решается с
1:01:09
помощью врачей и там не только в арсенале никотин замещающие препараты
1:01:15
жвачки пластыри там есть и Более серьёзные фармпрепараты которые стабилизируют вегетативную нервную
1:01:22
систему сердечно-сосудистую систему и помогает медикаментозно действительно

1:01:28
справиться с наименьшими симптомами с этой проблемой ваша задача информировать
1:01:34
найти Да тот того врача который поможет
1:01:40
Пациенту оказать такую
1:01:45
помощь Ну и собственно профессиональная помощь в отказе от курения
1:01:50
она во всм мире развивается
1:01:56
меди избавления от табачной зависимости в частности доказали свою
1:02:01
эффективность гипноз акупунктура лазерная терапия никотин заместительная терапия и даже вот как вы
1:02:09
видите в трей четверг ноября отмечается у нас международный день отказа от
1:02:18
курения собственно это прошло по инициативе врачей онкологов
1:02:27
онкологи они наиболее часто наверное из всех специалистов
1:02:33
сталкиваются с последствиями пагубным для здоровья Да со злокачественными
1:02:38
новообразованиями и онкологи они Собственно позиционируют уже курение не
1:02:43
как фактор риска вот онкологи Запомните пожалуйста они говорят что курение - это
1:02:48
не фактор риска рака фактор ри онкологических заболеваний они считают
1:02:54
что рение следственная причина рака причём рака любой локализации они
1:03:01
считают что каждый курильщик до курится до своего рака просто у кого-то это произойдёт Раньше у кого-то позже а
1:03:10
средний где-то срок развития онкологического заболевания - Это 15-20 пачка лет 15-20 пачка лет стаж
1:03:18
курения до развитие онкологии Ну это такой среднестатистический показатель у
1:03:24
кого-то раньше у кого-то позже причём речь идёт не только о раке тех органов
1:03:31
систем которые непосредственно соприкасаются с табачным дымом это не только лёгкий не только желудок куда
1:03:37
тоже Дым попадает в дыхани а рак любого фактически органа там это генетически
1:03:44

слабое место у человека там может разбиться онкология при значительном стаже курения
1:03:52
Ну в среднем где-то 152 лет то что у нас возраст а начала курения молодеет Да
1:04:00
начинают курить а иногда школьники подростки Да молодые
1:04:06
люди если вот он представьте себе в 15 лет а начал курить и курить начал так
1:04:13
плотно серьёзно Ну пусть там до 20 лет он привыкал втягиваться с 20 лет если он
1:04:19
перешёл на одну пачку сигарет в день то 20 и 20 лет в 40 лет вот вполне вот
1:04:27
пожалуйста то что видят врачи онкологи 40 лет молодые люди уже могут иметь
1:04:32
онкологическое заболевани если являются злостными
1:04:38
курильщиками поэтому помним что мы обязательно оцениваем у курящих людей
1:04:45
степень никотиновой зависимости если эта степень лёгкая мы можем работать Вы
1:04:50
можете работать с Не сами используя психологическое воздействие
1:04:56
здорового образ жизни коррекции поведения Если же это средняя и высокая
1:05:01
уже зависимость то подключайте пожалуйста специалистов
1:05:07
врачей это что касается курения Ну вот
1:05:13
также хотела некоторые инструменты дополнительные они для врачей описаны но вы если посмотрите
1:05:22
внимательно то здесь ничего такого И недоступного вам тоже нет вот
1:05:29
смотрите алгоритм консультирования курящего пациента Согласно тому же
1:05:34
источнику Да статья журнала профилактическая медицина алгоритм который состоит из пяти с 5S в чём они
1:05:44
заключаются первый с спросить да спросить спросить вы курите Как вы
1:05:51
курите каждый день не каждый день бросили не бросили Сколько СИ день да
1:05:56
Второй с Если человек курит то посоветовать посоветовать очень
1:06:02
аргументированно индивидуально Да оценить риск заболеваний связанных
1:06:07
курением и посоветовать отказаться от этой привычки третье с - это сверить

1:06:17
сверить то есть насколько клиент понимает все риски Да насколько
1:06:24
он понял вас услышал вас и насколько он готов готов он бросить курить или не
1:06:31
готов он бросить курить четвёртое с - это содействовать
1:06:38
содействовать в любом случае если человек не готов бросить курить значит
1:06:43
дать ему какие-то дополнительные информационные материалы какой-то буклет какую-то листовочник
1:06:52
почитал Да пригласить его ещё на следующую консультацию запланировать ещё
1:06:59
визит если он не совсем готов бросить курить если он сомневается то рассказать
1:07:04
ему о существующих методиках помогающих бросить курить поподробнее
1:07:11
Да порекомендовать консультацию специалиста который оказывает помощь
1:07:18
запланировать следующий визит также дать ему информационную
1:07:24
какую-то наглядную информацию какой-то буклет может быть
1:07:29
какую-то
1:07:35
[музыка]
1:07:54
листовочник ставить расписание расписание последующих визитов да то
1:08:00
есть как вы будете контролировать выполнение того плана который вы
1:08:05
составили вот с конкретными рекомендациями на предыдущем этапе вот такой алгоритм а краткого
1:08:12
консультирования курящего пациента называется 5С спросить советовать
1:08:17
сверить содействовать и Составить расписание для последующих
1:08:24
визитов а ещё очень один полезный инструмент тоже простой тоже предлагаю
1:08:29
вам им пользоваться как определить степень готовности бросить курить у
1:08:37
[музыка] клиента всего два вопроса всего два вопроса такой простой
1:08:43
опросник и Тоже варианты ответов оцененные в баллах от нуля до
1:08:51
четыр вопрос бросили бы вы курить Если бы это было легко

1:08:57
с вариантами ответов от крайнего определённо нет до крайнего определённо
1:09:03
да И второй вопрос как сильно вы хотите бросите курить от крайнего не хочу
1:09:09
вообще до однозначно хочу соответственно количество баллов за
1:09:15
два вопроса набранных клиентом вы мгновенно
1:09:22
складываю оценку готовности клиента либо он совсем не готов У него
1:09:28
низкая степень готовности либо у него средняя степень готовности он сомневается либо у него высокая степень
1:09:33
готовности бросить курить и тогда вам просто мгновенно нужно начинать с ним в этом направлении
1:09:41
работать и ещё один алгоритм уже мотивационного
1:09:48
консультирования для работы с клиентами которые готовы бросать курить
1:09:56
это алгоритм 5п уже да 5п по первым буквам
1:10:04
а п Первое - это первое п - это причина
1:10:09
отказа от курения да то есть э в целью мотивации а клиента вы находите
1:10:17
стараетесь подобрать такие индивидуальные причины для отказа от
1:10:22
курения которые подходят именно этому клиенту который его вот зацепят как за
1:10:28
крючок привяжут к себе и он будет идти к этой цели потому что она важна лично для него
1:10:36
Ну это всё очень индивидуально там в зависимость того кто мужчина женщина
1:10:43
молодой возрастной Да состояние здоровья наличие маленьких детей забо собственным
1:10:50
здоровьем собственной внешностью и так Дале и да
1:10:55
это последствия вторая п - это Последствия курения это
1:11:01
обсуждение всех а отрицательных последствий курения
1:11:09
Да с учётом всех ваших знаний Да поясняется все пагубные последствия
1:11:16
а то есть человек должен понимать ради чего он собрался это делать третий очень

1:11:24
важный пункт третье п - это преимущественно преимущество отказа от
1:11:29
курения Когда вы рассказываете человеку не только про плохое вернее не про плохое уже теперь
1:11:35
Рассказывайте А про хорошее что его ждёт в случае если он а сможет победить эту привычку если он
1:11:43
бросит курить значит что у него произойдёт хорошего что он приобретёт то
1:11:49
есть улучшится самочувствие Да восстановится что-то в сердечно-сосудистой системе
1:11:57
улучшение вкуса обоняние повышение работоспособности улучшение сна
1:12:02
улучшение цвета лица состояние кожи снижение всевозможных рисков
1:12:08
старения хронических заболеваний и так далее и так далее да то есть все преимущества перечисляйте
1:12:14
для данного конкретного человека четвёртое п в дам это ствие
1:12:25
препятствия У вашего клиента есть на пути отказа от курения То есть вы прямо
1:12:31
задаёте ему вопрос что на его взгляд ему мешает отказаться от курения обсуждаете
1:12:38
с ним все эти препятствия пробуете так сказать
1:12:44
скорректировать [музыка] и в основном Какие препятствия особенно
1:12:52
у тех кто [музыка] пытался это боязнь вот этого синдрома
1:12:58
отмена плохого самочувствия вот этой вегетативной бури А у кого-то боязнь э
1:13:04
набора массы тела Да у кого-то боязнь Э не справиться со стрессом с какими-то
1:13:12
неудачами а боязнь тратить удовольствие от этой привычки Да которые нечем
1:13:17
заменить то есть обсуждение препятствий А с поиском здоровой альтернативы так
1:13:25
чтобы эти все проблемы какие-то были решены И последнее п - это повторение
1:13:34
попыток а то есть при каждой встрече с клиентом
1:13:40
если Клиент не готов мы пытаемся его замотивировать повысить степень его
1:13:46
готовности если он готов Значит мы продолжаем работать повторяем все рекомендации

1:13:53
добавляем новые учитываем предыдущий опыт предыдущие попытки как работали те
1:13:59
или иные рецепты То есть прорабатываем анализируем если есть неудачи то
1:14:07
мотивируем не сдаваться да то есть продолжать попытки
1:14:14
И если в конце концов не получается то обязательно объясняем Куда обратиться за
1:14:22
помощью подключаем врачей и очень важно здесь настроить пациента
1:14:30
на то что у него может получиться это не быстро и не сразу то есть многие
1:14:38
курильщики проходят через повторные попытки Через несколько рыбов прежде чем
1:14:44
добиваются уже окончательного результата окончательно бросают курить
1:14:55
это соответственно механизм алгоритм 5п Вот который тоже
1:15:01
очень Мне кажется полезным инструментом с которым я вас хотела познакомить поподробнее
1:15:07
и ещё пару табличек из того же источника вот по поводу объёма помощи
1:15:15
курящим с разными статусами
1:15:22
курения Здесь вам просто Напоминание о том что если Клиент не готов бросить
1:15:30
курить мы ему даём информацию и потом повторяем Да если
1:15:38
пациент готов бросить курить но ещё не уверен у него средняя степень готовности
1:15:45
мы обязательно мотивируем рассказываем даём информацию при высокой степени
1:15:52
зависимости направляем специалистам к врачам которые оказывают
1:15:57
помощь а при низкой степени зависимости лёгких курильщиков мы можем попробовать
1:16:03
вести самостоятельно да у них больше психологической зависимости от этого процесса и
1:16:10
э при необходимости Мы также можем подключить никотин заместительную терапию которую назначит врач и самое
1:16:19
благодарные наши клиенты - это те которые готовы бросить курить на 7-10 баллов по шкале опроснику и в случае
1:16:27
если у них высокая степень зависимости если это бывшие

1:16:33
курильщики которые потребляют например электронные средство доставки никотина но они очень
1:16:39
хотят то обязательно рассматриваем при высокой степени фармакотерапия да
1:16:47
необходимость её подключения подключаем специалистов работаем с ними
1:16:55
и при низкой невысокой степени никотиновой
1:17:00
зависимости высокой готовности Ну есть большие шансы что мы справимся вы
1:17:05
справитесь самостоятельно с такими
1:17:14
клиентами данный слайд демонстрирует вам просто Спектр возможно конечно же это
1:17:22
для ознакомления иллюстрация того что есть разные препараты разные медикаменты
1:17:29
которые врачи назначают с учётом состояние здоровья
1:17:35
пациента вашего клиента с учётом всех показаний противопоказаний ваша задача только
1:17:41
обозначить что есть такая возможность обратиться к врачам которые назначат фармакологическую поддержку
1:17:47
лекарственный препараты которые по
1:17:57
это предлагаю вам активно пользоваться разными информационными материалами
1:18:07
листовочник Но чем больше фактов с разных
1:18:13
сторон пациент узнаёт о курении тем больше
1:18:25
материла пожалуйста раздавай их вашим клиентам Если есть вопросы по теме
1:18:31
курения напишите их пожалуйста в чат так я смотрю пока в чате опять
1:18:40
ничего у нас не появилось дополнительного Ну тогда я перехожу к
1:18:46
завершающей части и третья домашнее задание на выбор у нас было
1:18:51
оценка потребления алкоголя своего клиента родственника знакомого с
1:18:57
последующими обоснованными профилактическими рекомендациями по снижению потребления алкоголя
1:19:06
а тоже этот вопрос который вызывает у нас иногда бурные дискуссии на вебинарах

1:19:13
с вами много вопросов Аа забегая вперёд все мои ответы
1:19:22
сводятся к положению которые я цитирую экспертов всемирной
1:19:28
организации здравоохранения которые пришли к выводу которые считают что
1:19:34
несмотря на всякие разные виды и способы и культуры вино Тия существующее в мире
1:19:43
эксперты тем не менее воз считают что безопасных доз алкоголя для человеческого организма не существует
1:19:55
избыточное потребление алкоголя - это проблема актуальная для всего мира поэтому всемирной организации
1:20:02
здравоохранение Вот ещё в 2000 году озаботился
1:20:21
[музыка]
1:20:28
реальности Несмотря на то что безопасных доз алкоголя нет существует У нас вот
1:20:33
такая вот градация научные рекомендации по рискам употребления
1:20:39
алкоголя чтобы Мы всё-таки понимали О чём идёт речь
1:20:45
градации низкого умеренного и высокого риска для здоровья
1:20:52
которые оцениваются в зависимости от количества дринков алкоголя употреблённых в
1:21:02
неделю при этом один Дринк считается эквивалентен стандартной дозе алкоголя
1:21:08
которая содержит 17 мл чистого алкоголя То есть если для России мы возьмём то
1:21:13
это примерно 250 мл пила пятипроцентного или 100 мл Финан двенадцати процентным
1:21:20
алкоголем или 30 мл крепкого алкоголя согра градусной крепости а
1:21:27
соответственно благоприятно - это когда человек вообще не пьёт Да у него ноль дринков в неделю и
1:21:36
он здоровый у него Здоровый сон и благоприятно это в целом для здоровья
1:21:42
один-два дринка в неделю ассоциировано доказывало с небольшим отрицательным последствием для здоровья а при этом
1:21:50
шесть дринков в неделю уже повышают риск некоторых видов рака а семь и более
1:21:58

дринков в неделю то есть ежедневное употребление даже одной стандартной дозы повышает риск сердечно-сосудистых
1:22:06
заболеваний и инсульта И также вам в лекции напоминаю
1:22:12
был представлен тест русаудит то есть русифицированный адаптированный на
1:22:18
русском языке тест скрининг для выявления расстройств об условно
1:22:23
употреблением алкоголя собственно этот тест вы и должны были использовать для оценки потребления алкоголя у вашего
1:22:30
клиента здесь в общем-то нечего комментировать здесь понятные очень вопросы на которые в качестве анкеты
1:22:38
предложенной отвечает ваш клиент да сколько чего когда в каком количестве
1:22:45
Как часто он употребляет вы суммирует сумму баллов за его ответы и в зависимо
1:22:52
от того женщина оцениваете количество баллов для женщин потребление алкоголя более
1:22:59
пагубно Поэтому у них градации риска совпадают с
1:23:05
мужскими при меньшем количестве баллов И градация на четыре зоны четыре
1:23:14
зоны Это от ля доче баллов у женщин от Ну до баллов мужчин связа с низким
1:23:22
риском возникновения связа с употреблением алкоголя здесь в общем-то
1:23:28
можно воздержаться от каких-то так сказать комментариев либо
1:23:35
предоставить информацию в принципе о том что есть научные данные что неблагоприятно влияет
1:23:41
алкоголь на здоровье и в идеале лучше его исключить вовсе поскольку эксперты воз говорят нам о том что безопасно
1:23:50
стт Кост баллов мужчин от де до 13
1:23:57
то интерпретируется уровень риска как опасный уже то есть
1:24:05
увеличивающий риск возникновения вредных последствий для человека и здесь уже
1:24:11
нужно не только информировать пациента но и Настоятельно советовать ограничить
1:24:17
потребление алкоголя Если же у нас количество баллов у женщин 10 у мужчин 141
1:24:25

здесь налицо уже есть пагубное влияние употребления
1:24:30
алкоголя то есть оно приводит последствия физического
1:24:35
психического характера для здоровья человека и здесь
1:24:41
нужно не только консультирование вмешательства но и наблюдение у
1:24:48
специалистов учреждениях первичной медико-санитарной помо то есть здесь явно есть проблемы со зем которыми нужно
1:24:55
заниматься и совсем уже ситуация Крайняя когда у женщин 11 и более баллов по
1:25:02
данному опроснику мужчин более се то здесь уже практически диагностируется
1:25:10
алкогольная зависимость и клиент скорее всего уже нуждается в помощи
1:25:20
нарколога данное задание не вызвало В общем это у тех кто выбрал его в
1:25:28
качестве домашнего задания никаких сложностей Поэтому я считаю что здесь всё понятно
1:25:34
и Благодарю вас за внимание на этом вот
1:25:39
я запланированную часть нашего вебинара закончила А в качестве последнего совета
1:25:48
я вам всегда рекомендую начинать с себя в плане профилактики
1:25:54
хронических неинфекционных заболеваний в плане работы с управляемыми факторами риска во-первых Это послужит вам на
1:26:02
пользу оздоровление вас во-вторых это вам даст бесценный опыт то что мы прошли
1:26:09
сами преодолели сами остаётся с нами бесценным таким
1:26:14
опытом которым мы легко можем делиться и очень убедительно делиться с другими
1:26:22
людьми поэтому ещё раз вас благодарю за внимание и
1:26:27
А если есть вопросы прошу вас ещё раз
1:26:33
прошу написать их в чат либо включить микрофончик
1:26:39
Включить микрофон и задать вопрос Может быть что-то вы хотели
1:26:45
дополнить обсудить спросить уточнить пожалуйста
1:27:16
Ну что ж коллеги я смотрю что в чате никто ничего не пишет Надеюсь что всё

1:27:23
было понятно Надеюсь что информация сегодня ещё раз повторенная озвученная Дополненная принесёт вам
1:27:34
пользу и если вопросов больше нет тогда я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю
1:27:43
встречу мы с вами почти уложились не почти А точно уложились в лимит с учётом
1:27:50
того что мы 5 минут в начале подождали
1:28:01
коллеги Ну что ж ещё раз всех Благодарю за
1:28:13
внимание Анна Спасибо вам Вижу ваши сообщения в
1:28:18
чате Спасибо за лекцию не совсем лекция сегодня планировалась сегодня планировал
1:28:24
вебинара я хотела с вами что-то пообсуждали
1:28:33
я вас ещё раз благодарю за внимание Желаю вам успехов Напоминаю что на время
1:28:39
обучения мы с вами э на связи находимся если у вас вдруг потом после
1:28:45
сегодняшнего уже занятия возникнут какие-то вопросы Пожалуйста пишите их на платформу среда обучения через кураторы
1:28:51
мне их передадут и Я с удовольствием вам на них отвечу если вопросы возникнут
1:28:59
позже всё всем спасибо Успехов вам в вашей будущей
1:29:10
работе завершаем
1:29:21
конференцию Всего доброго коллеги а